QUESTIONÁRIO PARA PEDIDO JUDICIAL DE MEDICAMENTO(S)

Preenchido à mão pelo médico assistente (transcrição)

Paciente	Anselmo Rocha Teixeira
Atendimento que originou a prescrição	(X) Particular ( ) Convênio ( ) SUS
Medicamentos e posologia	Austedo 6 mg, 1 comprimido de 12/12 h por 7 dias; Austedo 9 mg, 1 comprimido de 12/12 h por 14 dias; Austedo 12 mg, 1 comprimido de 12/12 h por 7 dias, após manter 2 comprimidos de 12/12 h continuamente
Duração do tratamento	(X) Contínuo
Registro na ANVISA	(X) Sim
Previsto em PCDT da doença	(X) Não
Consta em padronização oficial (REMUME, RENAME etc.)	sem resposta
Há estudos de evidência científica? Qual?	(X) Sim. Qual: em branco

1. Doença e CID	Doença de Huntington, CID FO22
2. Características da doença	Coreia progressiva, necessitando da medicação para controle
3. Como é feito o diagnóstico	(X) Exame laboratorial. Doença genética
4. Finalidade do medicamento	(X) Paliativa. Reduzir a coreia
5. Existem tratamentos no SUS com a mesma eficácia?	“Não”
6. As alternativas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas?	( ) Sim (X) Não
6.3. Por que não foram indicados os medicamentos da rede pública?	“Não há tratamento para a doença no SUS”
7. Pode ser substituído por alternativa do SUS?	Não
7.1. Vantagens sobre os fármacos do SUS	Redução acentuada dos sintomas coreicos para melhora da qualidade de vida
8. O medicamento é imprescindível?	(X) Sim. Melhora da qualidade de vida
9. É urgente?	(X) Sim
10. Consequência da não utilização imediata	(X) Grave comprometimento do bem-estar. Não marcados: risco de morte; perda irreversível de órgãos ou funções
11. Quadro clínico	Coreia progressiva associada a quadro motor e demência
Local, data e médico	Porto Alvorada do Sul/MS, 20/01/2025. Dr. Henrique Salles Venturini, neurologista, CRM/MS 0000 (fictício)
Campos do paciente (convênio, tentativa no SUS, termo de consentimento)	Em branco

Dr. Henrique Salles Venturini, Neurologista
CRM/MS 0000 (fictício), Clínica NeuroVida, Porto Alvorada do Sul/MS

ANSELMO ROCHA TEIXEIRA
CPF: 000.000.000-00 (fictício)

Receituário

AUSTEDO (DEUTETRABENAZINA) 6 MG ..... USO CONTÍNUO
AUSTEDO (DEUTETRABENAZINA) 9 MG ..... USO CONTÍNUO
AUSTEDO (DEUTETRABENAZINA) 12 MG ..... USO CONTÍNUO

SEMANA 1: tomar 1 comprimido de 6 mg pela manhã e à noite
SEMANA 2: tomar 1 comprimido de 9 mg pela manhã e à noite
SEMANA 3: tomar 1 comprimido de 12 mg pela manhã e à noite
SEMANA 4: tomar 1 comprimido de 6 mg e 1 comprimido de 9 mg juntos pela manhã e à noite
SEMANA 5: tomar 2 comprimidos de 9 mg juntos pela manhã e à noite
SEMANA 6: tomar 1 comprimido de 12 mg e 1 comprimido de 9 mg juntos pela manhã e à noite
SEMANA 7: tomar 2 comprimidos de 12 mg juntos pela manhã e à noite

Tomar os comprimidos sempre com alimentos.

OBS.: seguir criteriosamente este receituário, sob risco de baixa resposta ou efeitos adversos.

24 de novembro de 2024
Dr. Henrique Salles Venturini, CRM/MS 0000 (fictício)

Os autos trazem duas vias desta receita, de igual teor.

Dr. Henrique Salles Venturini, Neurologista
CRM/MS 0000 (fictício), Clínica NeuroVida, Porto Alvorada do Sul/MS

ANSELMO ROCHA TEIXEIRA

LAUDO MÉDICO

Histórico clínico e diagnóstico. Paciente do sexo masculino com diagnóstico confirmado de Doença de Huntington, em seguimento desde 2016, com sintomas motores coreicos progressivos associados a distúrbios comportamentais. Apresenta deterioração funcional significativa relacionada à coreia, com impacto severo na qualidade de vida, no autocuidado, na locomoção e na socialização.

Tratamento prévio e atual. O paciente foi submetido ao uso de antipsicóticos típicos e atípicos, com resposta clínica insatisfatória:

- Haloperidol 2,5 mg à noite: resposta parcial, com sedação significativa e agravamento de sintomas extrapiramidais;
- Fenobarbital 100 mg à noite: sem eficácia comprovada para controle motor na doença;
- Escitalopram 10 mg pela manhã: mantido para sintomas depressivos.

Apesar dessas tentativas, não houve controle satisfatório da coreia, que continua limitando as atividades da vida diária e exacerbando os sintomas comportamentais.

Justificativa para uso de deutetrabenazina (Austedo). A deutetrabenazina é a única medicação com aprovação regulatória específica (FDA e EMA) para a coreia na Doença de Huntington; é inibidor seletivo do VMAT2 e reduz a liberação de dopamina nas vias motoras de forma mais segura e tolerável que a tetrabenazina. Ainda não está incorporada ao SUS, o que pode ser confirmado no site da CONITEC, e não possui substituto terapêutico de eficácia comprovada na lista do SUS. Os antipsicóticos disponíveis são de uso *off-label*, com evidência científica limitada e maior perfil de efeitos adversos.

Evidência científica. Estudos clínicos de alta qualidade, como os ensaios controlados e randomizados First-HD e ARC-HD, demonstraram que a deutetrabenazina reduz de forma estatisticamente significativa a coreia na doença, com melhor perfil de tolerabilidade. Esses estudos já estão disponíveis com tradução juramentada providenciada pela farmacêutica Teva, conforme exigência judicial.

Conclusão e recomendação. Diante do quadro motor refratário, da baixa resposta aos medicamentos atualmente disponíveis no SUS e da necessidade de melhorar a qualidade de vida do paciente, indico a deutetrabenazina (Austedo) como única opção clinicamente apropriada e respaldada por evidência científica robusta para o controle da coreia. Solicito a liberação da medicação, sob responsabilidade médica, conforme diretrizes clínicas internacionais.

24 de novembro de 2024
Dr. Henrique Salles Venturini, CRM/MS 0000 (fictício)

GENOMA DIAGNÓSTICOS (laboratório fictício)
Laudo de exame genético

Nome	Anselmo Rocha Teixeira
Sexo	Masculino
Solicitante	Dr. Henrique Salles Venturini, CRM/MS 0000 (fictício)
Sumário clínico	Investigação molecular de Doença de Huntington
Material	DNA extraído de swab bucal enviado ao laboratório
Coleta / entrada / liberação	28/09/2024 / 17/10/2024 / 21/10/2024
Exame	Doença de Huntington, expansão HTT (programa de apoio ao paciente do fabricante)

Resultado. Foi identificado um alelo com expansão patogênica no gene HTT: alelo 1 com 17 ± 1 repetições CAG; alelo 2 com 47 ± 1 repetições CAG.

Referência: alelo normal abaixo de 27 repetições; intermediário de 27 a 35; penetrância incompleta de 36 a 39; patogênico com penetrância completa acima de 39.

Método. Análise da expansão de trinucleotídeos (CAG) no gene HTT por *triplet repeat primed PCR* (TP-PCR). A técnica não distingue se a detecção de um único alelo resulta de homozigose ou de deleção na região analisada.

Comentários. O resultado (um alelo normal com 17 repetições e um alelo com expansão patogênica de 47 repetições) confirma a suspeita clínica de Doença de Huntington, distúrbio progressivo de herança autossômica dominante, com probabilidade de 50% de transmissão do alelo patogênico à prole. Recomenda-se aconselhamento genético.

Biólogo responsável
(fictício)

Diretor médico
(fictício)